

医医小草

宝辉

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们	3
序	5
医医小草	8
附：游艺志略	17

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望能有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

序

序

予友玉珊宝君，姿性杰出，好读书而尤致力于医，医书无所不窥，凡岐轩方术，与夫古今名家诸集，皆能潜心考究，默寻指归，如此者亦有年，其间或有因疑得悟，因悟得解者，爰撮其大要，着为论说，名之曰《医医小草》。予周览一过，窃叹宝君此书，能发前人之所未发，补古人之所不逮，使非洞明乎五运六气之机缄，七情九候之异同，以及脏腑虚实，经络源流，阴阳变化，气血周转，而又方药烂熟，临症甚多，安能如是之精审详备，不滋遗议也乎？吁，博学详说，尽宣医学之奥，使天下后世，凡业医者皆有所根据，宝君方功，诚匪浅矣。予少与君同学，备悉君之天姿英敏，立志甚大而锐，自离群而后，予虽稍稍涉猎方书，亦欲以术活人，而着述之事，自渐固陋，谢未能也。今读《医医小草》，深幸宝君既能医世，又能医医，行见此书之不胥而走，遂不计辞之工拙，乐而为之序云。

光绪二十有七年岁次辛丑季夏初吉砚愚弟春云倬清甫拜叙

序

医之难能也，孙氏思邈其知之乎？孙氏之着《千金要方》也。曰：“凡欲为大医者，必谙《灵》、《素》、《甲乙》、《明堂》、《流注》、《本草》、《药对》，以及仲景、叔和、阮、范、张、靳诸部经方，又须妙解阴阳禄命，诸家相法，灼龟五兆，周易六壬。若不尔者，如无目夜游，动致颠陨。”岂不以医之道，通乎造化，与阴阳五行相消息，不如是不足尽医之能事哉！今之世距唐远矣，孙氏所言诸术不尽传，诸经方亦多不可见。然自唐以来，千余年间，以医名者数十人。此数十人者，又各有所论著，以成一家之言，虽其中是非杂出，要莫不即其生平辛苦所仅获者，掬而告诸万世。自今观之，南北燥湿不同，古今禀赋亦异，执其一说，或且足以杀人。然则欲应无穷之变，而不窘于所施，不可不广览博采，以待一日之用明矣。顾今之悬壶者流，略识药性，请者造门，如《内》、《难》、《伤寒》、《金匱》诸书，不一寓目，遑问其他？晚近人情，乐简易而恶繁重，大抵然也。有本其师说，与其平日揣摩而有得者，约举以相示，不可谓非仁人之用心，而希捷获者之所甚便，然则玉珊是书之刻，其亦有不忍已者乎？余与玉珊遇于维扬书肆中，非素相识也。闻余购夏氏奇疾方未获，慨然出其家藏本假钞，因以是书属序。观玉珊之先施于朋友如此，其于疗疾处方又何如耶？书二种，号《医医小草》一卷，《游艺志略》一卷。玉珊富于年，异日读书愈多，研理愈深，吾知其所撰述，较今必更有进也。

望江何声焕顿首拜序。

序

宝子玉珊，余世好也。卓有大志，而酷嗜医，少时读《灵》、《素》、《玉函》诸经，有神悟。若熟识者，其谈医则按病施治，毫无难色。余尚不之信，适余患温病，十余日数易医矣。

玉珊为出一方，投之立效，始信玉珊之有得于医为不诬云。然余究惜玉珊之自小其志，而未观于读书致用之大也。而玉珊则视弃举之业，如弃敝屣，以为从事占HT，规规于记诵词章之末，即幸获一第，亦复于世何裨？是则玉珊之牢骚郁抑，因托于医以自见者。岁丙申余治装北上，赴部供职，而玉珊亦于是岁出游，由是天各一方，几及四年。旋余以读礼家居，就馆于鄂之抚署。季夏假归，玉珊亦先于前月旋里，握手道故，欢逾平生，出所着《易知录》、《医藉选》、《游艺志略》、《夜谈随记》各种而请序于余。余固不能辞，惜余少究心岐黄，未识玉珊医术，果能阐《内经》之奥旨，窥仲圣之秘蕴否？但自玉珊之立意言之，亦若惩世之庸医杀人，而有所不得已者，则以是延颈翘首而望之曰：玉珊之书，其传矣乎！是为序。

光绪庚子立秋之后一日前工部主事愚小兄迎喜雨亭甫识

自序

医学之难，难于无偏，无偏者仲景一人而已。厥后方书汗牛栋，以偏得名者莫胜于金元，如子和偏攻，丹溪偏补，河间偏凉，东垣偏温，入主出奴，愈趋愈下。而学古者泥古，执一家言，妄辨得失，非偏于寒证治法，即偏于温证疫证治法。殊不知寒温疫三证，包括者广，推之霍乱、疟痢、吐血、咳嗽，莫不各有斯三者，是三证明，而诸外感证，自迎刃而解。何偏之有？夫医本全生术耳。今习是术者，全生适足以伤生。盖欲人之生者，是其心。速人之死者，是其术。无他，医庸故也。天下多一明医，而所全者众，少一庸医，而所全者更众。兹编其欲化庸医为明医，俾使融会三者，同归于无偏而后已，未始非救偏之一助乎？

光绪辛丑夏仲西园居士撰于辅文书院之南轩

游艺志略自序

余自从朱爻生习医后，在皖南遇一友，周君潜初也。在扬州遇一师，叶君子雨也。余川广闽浙，足迹所经，知音者希。窃以不明营卫，血脉难通。不明三焦，气化何识？劳瘵，人只知虚而不知实。蛊胀，人只知实而不知虚。霍乱第知其为寒，消渴第知其为热，而不知凡病各有寒热虚实，偏则多弊。余不揣鄙陋，谨将得诸师友者，都为一卷，以公同好。颜曰《游艺志略》。盖持艺以游，游愈远而艺愈进，聊以备救弊补偏之一助，敢着述云乎哉！然亦仅可为知者道也。

光绪二十七年岁次辛丑仲夏月两湖钓叟自记

医医小草

精义汇通

滋腻妨中运，刚烈动内风

滋腻如天冬、麦冬、熟地、生地、石斛、蕤蕤、人参、阿胶、百合、蜂蜜、甘草、大枣、麻仁、文蛤、花粉、菊花、小麦、鸡黄、蚕砂、首乌之敛阴，刚烈如吴萸、丁香、川椒、干姜、肉桂、附子、硫黄、苍术、巴豆、草果之动阳，乃一时救急之药，非常病可久任之品。妨中运者，以土喜燥而恶湿。动内风者，以木喜水而憎火也。

辛热耗营液，温补实遂络

外感发表，辛药固不可少，如麻黄、苏叶、葛根、升麻、羌活之散气，桂枝、柴胡、荆芥、当归、川芎之行血，各有奇功，误用耗液，多变痉厥。内伤托里，温药亦未可废，如白术、黄、饴糖之补脾，杜仲、菟丝、故脂之补肾，非无幸中，第过用阻络，定患药癖。二者皆能助邪而益病，主用者，不可不慎。

苦寒伤生气，咸润蔽太阳

热在气分，宜甘寒，在血分，宜苦寒，尽人而知，据时令言，春温，秋燥，甘寒用处甚多，惟夏外阳内阴，则宜苦以燥湿，寒以胜热。然胃阳素虚者，自不可过投。而《金匱·吐衄》篇三黄泻心汤云：治心气不足，西昌谓培生气而坚脏。诚然，何医只知有倒胃之弊哉？其药如大戟、甘遂、葶苈、防己、知母、大黄、黄芩、黄连、栀子、丹皮、青黛、木通、苦参、龙胆草、鸦胆子之类是苦寒，虽有清实热之益，弊与滋腻同，不再赘。咸寒如鳖甲、蟹壳、僵蚕、蝉蜕、蛇皮、蜣螂、水蛭、虫、海藻、紫葳、文蛤、牡蛎、秋石、戎盐、人中白、肉苁蓉、桑螵蛸、元明粉之属，软坚，清燥，却风火，攻宿血，非无捷效，用之过当，心阳蒙蔽，而神明为之不灵，精血为之日削矣，司命者尤当急知之。

外感忌酸收，内症戒消导

酸收如枣仁、榴皮、五味、乌梅、诃黎勒、罌粟花、宣木瓜、山茱萸，涩可固脱似也。设有一毫外感，令邪永无出路。即系内伤吐血、咳嗽之证，反致成劳。观仲景用乌梅，必用川椒，用五味，必用干姜，用麦冬必用半夏，用枣仁必用川芎，其意深矣。内伤之证，有阳亏于外者，有阴虚于内者，彼茱萸、茯苓、泽泻、滑石、瞿麦、石韦之利溺，牵牛、芒硝、大白、大青、大黄之滑肠，切勿乱投。即兼有外感，则麻桂发汗，瓜蒂、皂角探吐，更宜酌用。伤寒有云：亡血家不可发汗，疮家亦

不可汗，湿家不可下，是其例也。乃暴病忌参、术、黄、熟地，沉、枳、朴、桃仁、山楂，亦可类推。

合观四节，可审用药之法。

二妙不尽妙，四神亦非神

苍术、黄柏，一生一熟，偶方中之小剂，湿热证之妙方，所以二妙命名。究竟治湿重于热者则妙，若热重湿轻，当加入知母、地榆较妥，而风湿寒湿，终非其治也。故脂、豆蔻、吴茱、五味，四药合丸，治食后脾泄、五更肾泄神效。殊不知脾肾之泄，有命火虚者，有肝火炽者，徒以为神，即有增病速死之神矣，可知方书中，随意命方者，如八珍、十全、固本、保真之类，不得以其名目好看，而妄投不计。但四君子扶脾，谁谓不善？以治脾虚，可称君子，若遇胃实，何异小人？盖方无论平奇，要在对证。

白虎固金佳，青龙驱水捷

虎啸风生，其热自平，凡火刑肺胃，当推白虎第一。若火在肝肾，即芩连阿胶鸡子黄汤、白头翁汤之证治，此方未能胜其任。胃有实邪，粳米又宜减之。而小青龙，桂枝开天，细辛通地，复有姜、夏、麻、草温中以散其外，芍药内助以托其邪，面面周到，无微不入，故洄溪谓为治寒水之神剂。发汗利水，并可补四逆、真武之不逮。然温邪咳嗽，误投必毙。大青龙发汗亦然。是二法乃一大寒大热之对子，泻心、四逆，庶堪比肩。

理中伤胃脂，逍遥劫肝阴

理中汤之醒脾，逍遥散之疏肝，洵为良方，然治气分不足则可，若以之治血虚之体，是增病而速毙。凡方皆利弊相因，彼偏用二方者，何徒知其利而不计其弊哉？

牛黄损离火，黑锡夺坎水

一清心中痰火，一摄肾下寒水，诚医家宜备之要药。然备以治仓猝闭证，则有无穷之益，误施于久延脱证，其害不可胜言。苏合香丸治气闭，大活络丹治中风，损益同此。

合观四节，可以悟投方之机。

温寒须行气，清热要活血

气滞而后寒积，血壅而后热生。行气如旋复、香附、陈皮、葱、薤等味，加入温药队中以散寒，其效倍捷。清热苦寒，甘寒咸寒诸药，大剂寒凉，必加入活血之品，如桃仁、丹皮、泽兰、茜草、刘寄奴、参三七等，乃无冰伏热邪之弊。此理本易知，惜医多不识，故特表而出之。

命方良有以制剂岂徒然

方有膏、丹、丸、散、煎、饮、汤、渍之名，各有取义。膏取其润，丹取其灵，丸取其缓，散取其急，煎取其下达，饮取其中和，汤取其味，以涤荡邪气，渍取其气，以留连病所。而君臣佐使，配合全在分量，如小承气用大黄为君，走中下焦血分，浓朴为君，即变而为中上焦气分之法。阳旦汤桂枝为君，走太阳，芍药加倍，便入太阴。当归赤小豆散，赤豆为君，重在败毒，当归为君，重在理血。主之，佐之，轻之，重之，运用之妙，存乎一心，立方者讵可忽诸？

六经提纲

仲景《伤寒》一书，乃统治外感之书，非专治风寒者也。六经分明，寒温疫三证，均晓然矣。兹录提纲于下曰：“太阳之为病，脉浮，头痛，项强，而恶寒。”“阳明之为病，胃家实是也。”“少阳之为病，口苦，咽干，目眩，耳聋。”“太阴之为病，腹痛，自利，时时呕吐。”“少阴之为病，但欲寐是也。”“厥阴之为病，消渴，气上冲胸，饥不欲食，食则吐蛔，下之利不止。”

六字真言

无论外感内伤，无论出其右者，莫六字若也。曰表，里，寒，热，虚，实。三阳为表，三阴为里。表中之里，阳明是也，里中之表，少阴是也。并各相表里。三阳之腑主表，经主里。三阴则心肺主表，脾肝肾主里。外感者表宜汗，里宜下。内伤者表宜清补，里宜温补。内伤阳则阴盛，阴盛者易感寒。内伤阴则阳亢，阳亢者易感热。此所谓邪乘虚入也，虚为正虚，实乃邪实。故经云：“邪气盛则实，精气夺则虚。”医能将此参伍错综，条分缕晰，则亦庶乎其可也。

六气便解

风

风有内外。内动之风病于肝，治当辛凉。

外感之风病在肺，治当温散。兼寒脉紧，兼湿脉弦，燥化脉数，寒化脉迟，本病脉浮。

寒

寒有表里，而表里各有虚实。实者解表，宜麻黄汤，攻里宜三物白散。虚者固表，宜桂枝汤，温里宜四逆汤。兼风脉浮，兼湿脉沉。

暑

天热地湿，合而成证，暑气当令，因时命名，邪实脉洪，正虚脉濡。

湿

湿有清浊。露雾湿伤气分者曰清，潮水湿伤血分者曰浊，清宜发汗，浊宜利水。从燥化则脉急，从寒化则脉缓，本病脉滑。

燥

燥有虚实，虚燥救肺，实燥浮心，酸甘凉润，始终正治，邪实脉涩，正虚脉短。

火

火有阴阳，阳火可釜底抽薪，阴火宜导龙归海，阳脉有力，阴脉无神。

医经补正

服桂枝汤，大汗出，脉浮大者，与桂枝汤如前法。若形如疟，日再发者，汗出必解，桂枝二麻黄一汤主之。

脉浮紧者，病在表，可发汗，宜麻黄汤。脉浮而数者，可发汗，宜麻杏甘石汤。

伤寒脉浮缓，身不疼，但重，乍有轻时，无少阴里证者，越婢汤主之。

伤寒脉浮滑，此表有热，里有寒，白虎加桂枝汤主之。

寒实结胸，无热证者，与三物白散，小陷胸汤亦可用。

伤寒身黄发热者，麻黄连翘赤小豆汤主之。伤寒瘀热在里，身必发黄，栀子柏皮汤主之。

伤寒心下有水气，咳而微喘，发热不渴，小青龙汤主之。服汤已渴者，此寒去欲解

也。

伤寒脉浮紧无汗，发热身疼痛，八九日不解，表证仍在，此当发其汗，麻黄汤主之。

服药已微除，其人发汗，目瞑剧者，必衄，衄乃解。所以然者，阳气重故也。

伤寒不大便六七日，头痛有热者，与承气汤。小便清者，知不在里，当须发汗，宜桂枝汤。苦头痛者必衄。

太阳病寸缓，关浮，尺弱，其人发热汗出，复恶寒，不呕，但心下痞者，此以医下之故也。病患不恶寒而但渴者，此转属阳明也。其不可下者，小便数者，大便必硬，不更衣十日，无所苦也。渴者宜五苓散，渴欲饮水者，少少与之。

病发于阳，而反下之，热入，因作结胸。病发于阴，而反下之，因作痞。所以成结胸者，以下之太早故也。所以成痞者，误下故也。

金匱云：阳毒咽痛吐脓血，面赤斑如锦纹，升麻鳖甲汤主之，阴毒面青如蓝靛，身痛如被杖，升麻鳖甲去雄黄蜀椒主之。

金匱云：病微饮，短气，苓桂术甘汤主之。肾气丸亦主之。

治病法解一

治外感如将，（意在去其所本无，所谓急则治标。）治内伤如相，（意在复其所固有，所谓缓则治本。）治心肺如羽，（药当从轻）。治脾胃如衡，（药当从平。）治肝肾如权。（药当从重。）

治病法解二

古人治外感，有汗吐下三法。治内伤有温清和三法，其实皆治肺胃也。肺寒实则汗之。胃寒虚则温之。肺胃虚热，治以清和。肺胃实热，治以吐下。此至当不易之法，时医不识，调理肺胃，归宗脾肾，去古远矣。

素问摘要

脏腑为病者：心为噫，肺为咳，肝为语，脾为吞，肾为欠为嚏，胃为气逆为哕为恐，大小肠为泄，下焦溢为水肿，膀胱不利为癃闭，不约为遗溺，胆气郁为怒。诸病所属者：诸风掉眩，皆属于肝。诸寒收引，皆属于肾。诸气郁，皆属于肺。诸湿肿

满，皆属于脾，诸疮痛痒，皆属于心。诸痿喘呕，皆属于上。诸厥固泄，皆属于下。诸暴强直，皆属于风。诸病水液，澄澈清冷，皆属于寒。诸呕吐酸，暴注下迫，皆属于热。诸胀腹大，诸病有声，按之如鼓，诸转反戾，水液混浊，皆属于热。诸痉项强，皆属于湿。诸热瞀，诸禁鼓栗，如丧神守，诸病跗肿，疼酸惊骇，诸逆冲上，诸躁狂越，皆属于火。四时所病者：春善病鼽衄，仲夏善病胸胁，长夏善病洞泄，寒中，秋善病风疟，冬善病痹厥，此病机之要旨也。

风淫于内，治以辛凉，佐以苦甘，以甘缓之，以酸泻之。寒淫于内，治以辛凉，佐以甘苦，以咸泻之。暑淫于内，治以咸寒，佐以苦甘，以酸收之。湿淫于内，治以苦热，佐以酸辛，以苦燥之，以淡泄之。燥淫于内，治以苦温，佐以酸辛，以苦下之。火淫于内，治以咸冷，佐以苦甘，以酸收之，以苦发之。此治法之要则也。

三证合参

发热，汗出，恶风，脉缓者，名曰中风。恶寒，体疼，呕逆，脉寸尺俱紧者，名曰伤寒。此风寒脉证之提纲也，分言之六经，各有专证，各有异脉。太阳受病，寸尺俱浮。阳明受病，寸尺俱长。少阳受病，寸尺俱弦。太阴受病，寸尺俱细。少阴受病，寸尺俱弱。厥阴受病，寸尺俱微而缓，故曰脉异。太阳汗不出名伤寒，汗自出名中风。阳明能食为中风，不能食为伤寒。少阳耳聋，目赤，胸满，心烦，为中风；头痛，发热，而脉弦细，为伤寒。太阴中风，手足自温，伤寒自利，不渴。少阴中风，自利而渴，伤寒欲吐欲寐。厥阴中风，舌卷囊缩，伤寒饥不欲食。故曰证专在三阳，脉则浮，三阴脉则沉，其缓紧迟细则一。若浮不缓，不紧，而滑数，沉不细，不迟，而濡急，则即风温与湿温之脉。再审其证，庶无错误。至于阳证见阴脉，阴证见阳脉，舍从两难，乃系疫证，与寒温异治矣。

寒本阴邪，何以伤寒证中又有中风？温乃阳邪，何以温证之中，又有湿温？要知阴中有阳，阳中有阴。寒证中伤寒是主，中风是宾。温证中风温是主，湿温是宾。湿温与伤寒相对待，风温与中风相对待。而疫则有寒有温，温疫是其常，寒疫是其变。知常知变，知对待，知宾主，可与言阴阳互根之理矣！彼囿于一偏者，不肆用寒凉，即概用温补。曾亦思偏寒偏热之证，不多见耶。

说寒

寒最要者，表里二字。而表里中，又有兼风兼湿之别。风寒病太阳，湿寒病太阴。伏气治少阴，感冒治少阳。第拘标本言，少阴太阳司此气耳。余惟太阴亦多，至少阳阳明厥阴三经，即系寒病，每从热化，和解可也。当与前六气参看。

说温

温热之论，叶香岩寻其源。风湿之分，陈平伯溯其流。厥后吴氏鞠通，祖述叶案，而着《条辨》。王氏孟英，宪章平伯，而纂《经纬》。治温津梁诸书备已。然一则界划三焦，一则伏气未达，智者一失，殊为二先生惜。今将风湿分两段，持前人言，以明其义，庶长夜一灯，不致盲人摸索。

风温

吴鞠通曰：风有温有寒。风寒之风，此风从北方来，乃触发之寒风也。最善收引，阴盛必伤阳，故首郁遏太阳经中之阳气，而为头痛，身热等证。太阳阳腑也，伤寒阴邪也，阴盛伤人之阳也，故曰风寒。风温之风，此风从东方来，乃解冻之温风也。最善发泄，阳盛必伤阴，故首郁遏太阴经中之阴气，而为咳嗽，自汗，口渴，头痛，身热等证。太阴阴脏也，温热阳邪也，阳盛伤人之阴也，故曰风温。

湿温

叶子雨曰：湿温之因有三，阳脉濡而弱，阴脉小而急，此先受暑，后中湿，乃暑邪蒸湿者是也。证见两胫冷，腹满，又胸头目痛，妄言，治在足太阴，不可发汗。由先伤于脾，因而中，湿热相搏者是也。脉濡弱，舌苔白或绛底，呕逆口干，不能汤饮，胸满闷，身潮热，汗出稍凉，少顷又热，此春分后，秋分前，少阴君火，少阳相火，太阴湿土，三气合行，加以天气热下降，地气湿上腾，由口鼻吸受，着于脾胃者是也。误治变证，非一端所能尽。夫湿自外来，上焦气分受之，潮热，自汗，表之不解，清之不应，宜宣通气分。若冒雨雾，湿留太阴，肌表发热，自汗，不渴，不饮，舌苔灰白，粘腻，身虽热，不欲去衣被者，宜解肌和表。论证不清，鲜有不僨事者。

说疫

疫者，役也。犹徭役之谓，多见于旱潦兵燹之余，烈日郁蒸，尸骸之气，与亢胜之气，混合化而为厉毒，散漫于天地之间，受之者大则一郡一城，小则一村一镇，互相传染，所感之因虽同，所患之证不一。如东坡所论寒湿之疫也，东垣所论虚疫也，吴又可所论湿热相搏之疫也，余师愚所论暑燥之疫也，故刘温舒《素问遗篇》有五疫之刺，庞安常《总病论》有五色之治，然不可泥也。越人《五十八难》言，伤寒有五，其中风，伤寒，湿温，热病，证脉委曲详尽，行在诸经，不知何经之动也。盖随其经所在而取之。盖天地厉之气，不可以常理测，不得以常法治。彼见温病，动手发汗，是误以伤寒法治温病。每遇疫病，往往失下，则又是以温病法施治于疫，更误之甚矣。

辨证

发热

寒证发热恶寒者，病发于太阳也。无热恶寒者，病发于少阴也。温疫发热是潮热，非若伤寒壮热，初起间有恶风，及次日即口渴畏热。而疫证憎寒壮热，有如瘧症是已。

呕利

少阳胆木，挟火披猖，呕是上冲，利由下迫，此谓风温之呕利也。中虚始利，聚饮而呕，此湿温之呕利也。若夫胃气不降，肺气不和之呕利，疫多有之。盖或温或疫，凡呕利者，是其邪之出路，不可遽止，寒病反是。

诸痛

头痛目痛，太阳阳明伤寒者不至侧倾难举，温与疫则头痛如劈，两目昏瞽，势若难支，骨烦疼，腰如被杖。寒病责在伤阳，温疫责在亏阴。

肢冷

在寒证是肾阳不通，在温证、疫证是肝阳不宣，所以寒踞少阴，与热伏厥阴有别。

鼻衄

寒证见之是邪气之将退，温疫见之乃邪气之正进。

蓄血

寒证当汗不汗，热结膀胱，温疫当下失下，火郁膜原，均有此证。凡发热不退，小便自利，其人如狂，而喜忘者皆是。

治法

寒病宜汗者，是外感之风寒。而中寒则宜温，虽有里证，总以先汗后下为是。温病风温慎汗，治当辛凉，湿温禁下，治宜苦寒。疫病表里双解，内外分消，偏汗偏下，两非所宜。

指南

病证有相类者，不可不辨。湿从寒化曰痹，湿从热化曰痿。中风，寒中衰食饮，热

中消肌肉。厥冒血厥由风，气厥由痰，煎厥是风，薄厥是热，痛厥是寒，蛔厥是湿。此风痹痿厥相类而实殊。重阳者狂，重阴者癫，阴阳相搏者痫，津液两亏者痉，此癫狂痫痉，相类而实殊。

清不升则呕，浊不降则吐，清浊不分则嘔，营卫不和则噫，此呕吐嘔噫，相类而实殊。气分六聚，癖是已，血分五积，瘕是已，此瘕癖，相类而实殊。虚损宜补精，劳瘵宜攻血，蛊宜开肺，膈宜调胃，此蛊膈虚劳，各从其类。

黄瘧黄汗，湿与风别，脏结脏燥，寒与热分。咳嗽当别痰饮，消渴须分寒水。水逆火逆，少阴手足不同。风温湿温，太阴手足各异。九痛七疝，虚实自喜按拒按而定。三冲五郁，燥湿由善怒多恐而明。各门别类，毫厘千里，医当辨记，勿谓不然。

审脉

浮沉以审表里之虚实，迟数以审脏腑之寒热，大小以审邪气之进退，长短以审正气之浓薄，滑涩以审血气之盛衰，左右以审生克之顺逆，合望闻问思过半矣。此所云者，聊举一隅，是在善悟者，触类旁通可耳。

附：游艺志略

营卫，血气也。何以《内经》或云一昼夜五十周于身，或云一昼夜一周于身？其运行之道，生会之理，盍详陈之。

答曰：一阴一阳之谓道，有三气存乎其间。譬如阴静也。阳动也。所以使其动静者，又一也。识此则明三才之指归，知互根之为用矣。营主血，卫主气，然营血何以能循行经脉，卫气何以能濡润皮毛？盖血中有气，气中有血，不可斯须之相离，此即阴阳互根之理也。请参中西之说以证明之。西士言食入于胃，其精汁有微丝液管吸至颈，过肺入心，化赤为血，由总脉管达下焦，散布十二经脉，此即行十六丈二尺，脉道以应漏水百刻，五十度周于身之营血也。经言营气之道，内谷为宝。谷入于胃，乃传之肺，流溢于中，布散于外。精专者，行于经隧，常营无已，终而复始。又言人受气于谷，谷入于胃，以传于肺，五脏六腑，皆以受气，其清者为营，浊者为卫，营在脉中，卫在脉外，周营不休，五十而复大会，阴阳相贯，如环无端者是也。人之饮食五味杂投，奚能无毒？其清者，奉心化赤为血。其浊者，积于胸中，随经脉中之血气，出诸气街，散布周身，以卫护阳气，故谓之卫气。西士言血由脉管之尾，入微丝血管，缠布周身，以充肤热肉。其所谓微丝血管者，孙络也。微丝血管之血行遍周身，渐并渐粗，而入回血管。回血管者，络脉也。血入回血管，则其色渐变为紫，中含毒瓦斯故也。其管两支，一支向上，一支向下，皆与十二经脉，逆顺皆行，至总回管入心右房，由心至肺，呼出毒瓦斯，吸入生气，其血复变为赤。

从心左房而入总脉管，往来如环，昼夜不息。经言谷始入胃，其精微者，先出胃之两焦，以溉五脏，别出两行营卫之道。其大气搏而不行，积于胸中，命曰气海者也。西士言脉管内其血行速，微丝血管内，其血行迟，查得总脉管内，每秒时行十二寸，足脉管内，每秒时行二寸有奇，微丝血管内，每分时只行一寸。经言卫气之行，一日一夜五十周于身，昼行阳二十五度，夜行阴二十五度，周于五脏。又言卫气常一日一夜，大会于风府，日下一节，二十一日下至尾，二十二日入脊内，注于伏冲之脉，其行九日出于缺盆之中，其气上行者也。

夫《营卫生会篇》所谓一日一夜，五十度周于身者，乃奉心化赤之血，由心入总脉管，散布三阴三阳之十二经脉，行八百十丈脉道之营气也。《岁露篇》所谓一日一夜，行身一周者，乃脉管之血气，由三焦气街，出诸孙络，挟阳明悍气，缠布周身，充肤热肉，淡渗毫毛之卫气也。《营卫生会篇》所谓昼行阳二十五度，夜行阴二十五度者，乃络脉中之气血，行遍周身，渐并渐粗，而入络脉也。络脉有阴阳之分，阳络浮于肤表，阴络沉于肌里，皆与十二经脉管交相逆顺而行。缘人昼则寤，寤则动，动则阳气浮，故络脉中之气血，行阳络者多。夜则寐，寐则静，静则阴气沉。故络脉中之气血，行阴络者多。是皆奉心化赤之血，从经脉而行孙络，从孙络而入络脉，一气营运，循环不息耳。然经以清者为营，浊者为卫，此中界限，分划甚

严。盖脉管之血色红，既出三焦气街，入孙络色即兼紫，挟阳明悍气之毒故也。入络脉其紫色较重，必待入心出肺，呼出此毒瓦斯，吸入生气，其血复变为赤，落心左房，而入脉管，是脉管中营运之血气，为营，清而无毒也。孙络络脉中之气血为卫，浊而有毒也。学人当知同一荣养百骸之气血，而泾渭分明，不容紊乱也明矣。其治病大法，亦当从兹悟入。风寒由毛窍袭入者，宜达表。由口鼻吸受者，宜攻里。沙瘴一证，刮则泻孙络中之热毒，刺则泻络脉中之热毒，故刺出之血紫病轻，深紫病重，色黑则危。盖暑秽之毒，随阳明悍气，至总脉管，入心，入心则死矣，凡百伤寒温暑，从可类推也。若夫《岁露篇》所谓卫气之行，一日一夜，大会于风府，日下一节，九日而上出缺盆，与一日一夜，五十度，周于身之行度，迟速不侔者，盖出三焦气街，入孙络之气血，缠布周身，如日绕天之外，故其行迟。经脉阴阳逆顺偕行络脉中之气血，如月行地之中，故其行速。或谓江河窄处水流急，宽处水流缓，何以脉管阔处血行速，而出气街之气血，挟阳明悍之气，何以行迟？斯说亦颇近理，江河窄处其流急是矣。若支派分流，则细港浅渠，其泄亦迂缓，阳明悍之气滑疾是矣，若散漫不收其气，亦力弱行迟。况亿万分派之微丝血管乎？势分行缓，理势然也。虽然，此犹日月营运，阴阳造化自然之理，非知力所能臆度者也。《卫气篇》黄帝所云：亭亭淳淳乎，孰能穷之？其斯之谓欤。

外感重病，因四时之有伏气也。伏气不明，何疗外感？张隐庵非不知也，惜于反复辩论中，多有词不达意者，继而王孟英议吴鞠通略伏气，而自强侈谈，毫无实际，愿闻其说。

答曰：《素问·阴阳应象大论》曰：重阳必阴，重阴必阳，故曰冬伤于寒，春必病温，春伤于风，夏生飧泄，夏伤于暑，秋必疟，秋伤于湿，冬生咳嗽。此四时伏气之机，尤重在“重阴必阳，重阳必阴”八字，以明阴阳互根之义也。何以言之？伤于风者上先受之，伤于湿者下先受之。风为阳邪，阳病者上行极而下，是以春伤于风，夏生飧泄，此重阳必阴也。湿为阴邪，阴病者下行极而上，是以秋伤于湿，冬生咳嗽，此重阴必阳也。冬伤于寒，春必病温者，冬至一阳渐生，人身之阳热内盛，被严寒之气，折伏于肌髓之间，至春阳气盛长，伏邪浅者，亦可随春阳之气渐散，伏邪深者，或因风寒所遏，或为嗜欲所伤，伏结之阳气，遇天气之阳热，两热相干，发为温病，此重阴必阳也。夏伤于暑，秋必疟者，夏至一阴渐生，人身之阴气内盛，暑乃阳邪，阳气外炽，则里气虚寒，加以贪凉饮冷，损其真阳，至秋阴气之时，内伏阴邪欲出，外袭阳暑欲入，阴阳相持，故发为往来寒热之疟，此重阳必阴也。是即伏气是即外感之源也。再求精详，自有子雨之《伏气解》在。

生气通天论云：其生五，其气三。何谓也？

答曰：天地阴阳一气而已，自太虚而有太乙之生，气由是动静焉。而阴阳分，阴阳分而五行具，是五行之生，不离夫阴阳之一气也。而经曰其生五，其气三。且曰三而成天，三而成地，三而成人。是三气者天地人之本始也。请试明之。太极无形，

静则为阴，动则为阳。易曰“一阴一阳之为道”。此一阴一阳，非各一之一，乃道之妙用，而合一之一也。惟其合一，乃能各一，则是其本一而已。有三气存乎其间矣，是故动与静各一也。

而所以能动静者，又一也。由此观之，太乙之所施生，造化之所鼓铸，必得三而始能成。

物气不得三则无以布于五，而五非得三，又不能各致夫一也。三者一之用，五者三之成也，故三而成天。立天之道，曰阴与阳，天总阴阳，而又积阳以自刚也。立地之道，曰柔与刚，地致柔刚，而又积阴以自奠也。立人之道，曰仁与义，然理以宰气，而气以宰理，故人之成也。本乎气交，禀天之阳动为气，本地之阴静为精，而有神存乎其间，以立性命之基。是精气神三者，合而不离，所谓三而成人也。且太极用此三气以生五行，而五行之生，又莫不各用夫三气。试就人之五脏言之。心为太阳而主血脉，是合阴阳而自为阳也。肾为太阴，而涵命门真火，是合水火而本为阴也。肺主制节，而水出高源，是合金木水以行气也。肝为血海，而生一阳，以升太冲，是合水木火而总于厥阴也。脾上承火，下涵水以奠乎中，火以腐熟，水以滋灌，而土以归藏，是合水火土而养四脏也。故知阴阳之致，相待为用，阴阳之根，互藏其舍。

而五行之变化，皆非一气偏至之所成，盖一有偏至，而合三则无偏至，一无鼓动，而合三则能鼓动，人徒知为三，而不知合三而后致夫一也。从知生于一，而不知用于三，而后全夫生也。自轩岐指出三气，而造化之妙用始彰，故三五与一，太上之玄阃，养生奥关也。

《三十二难》有曰：肺白象金，肝青象木，金得水则沉，木得水则浮，何以肺浮肝沉？乐火乐金，其合化之道，可得闻乎？

答曰：十干合脏腑，甲阳木应胆，乙阴木应肝，丙阳火应小肠，丁阴火应心，戊阳土应胃，己阴土应脾，庚阳金应大肠，辛阴金应肺，壬阳水应膀胱，癸阴水应肾。若以五音配五行，营土，商金，角木，征火，羽水。各因十干之阴阳、而分太少也。肝属乙，木得水当浮，何以反沉？然肝虽乙木，乙与庚合，庚为阳金，金性本沉，妇当从夫，其意乐金，而失木之本性，故得水反沉也。肺属辛，金得水当沉，何以反浮？然肺虽辛金，辛与丙合，而为阳火，火性炎上，妇当从夫，其意乐火，而失金之本性，故得水反浮也。生则生气旺，故能合化。熟则生气尽，故不能合化。所以肝熟而复浮，肺熟而复沉，乃返本还原也。大而言之，天地之阴阳。小而言之，即人伦之夫妇。其理一也。夫肝属足厥阴经，位乎膈下，故行阴道多也。肺属手太阴经，位乎膈上，故行阳道多也。今举肝肺类推，则脏腑阴阳之合化，从可会通矣。然阴阳之理，以和为洽。夫妇之道，非协可成。

合化之义，未有明其所以然者，虽张隐庵、高士宗、汪双池、张翼元诸家，不以翼軫分疏，即用生克定论，似是而非，支离颇多。惟罗淡生《内经博议》，引申《天元玉册》之义，最为晓畅。今节录于下：岐伯述《天元玉册》曰：太虚寥廓，肇基化元，万物资始，五运终天，布气真灵，总统坤元。夫肇基化元，而布气真灵，乃云总统于坤元，是坤元为万物之母也。坤元既为万物之母，而总统之，而天亦必先有以用之也。天之十干，以戊己居中宫，而先用水火，然后成于金木，岂非总统坤元而以土为首之义乎？是以天之御化，首以土为甲，而甲遂为土，仍顺布五行于乙丙丁戊之上，而以本气化之，土生金，金加于乙，金生水，水加丙，水生木，木加丁，木生火，火加戊。五行毕，再传而土加于己，故甲己合也。金加庚，故乙庚合也。水加丙，故丙辛合也。木加壬，故丁壬合也。火加癸，故戊癸合也。因合而化，此一定之理，有不可移易者也。然本气之阴阳，仍有不能从化，而根据之以为用者，如加阳干为气有余，加阴干为气不足，此又因值年以佐用也。

昔贤论三焦一府，纷纷聚讼，莫衷一是，或谓无形，或谓有形，或言是一，或言是二，甚则云为肾傍之脂者，虽明如张隐庵，亦游移其词，不能指为何物，《内经》谓上焦如雾，中焦如沤，下焦如渫，岂虚语哉？

答曰：考脏腑之学，西士言之最详，观《全体通考》，三焦即所谓腹包膜也。其膜包绕全腹，上通颠顶，下行膀胱，中有脂膜，横于肝胃之间，惟遮阴道，护子宫，则男女稍异耳。或问复包膜即三焦，亦有证据否？曰观其包二肠，遮两肾，正当七节之间，命门部位。命门既藏水中，真火，即为相火之宅，居其位，行其权，此膜即为相火之腑。考心肺之下，肝胃之上，有膈膜一层，其形薄如细纲，上与心包络之下面相连，下与此膜之上层粘续，气脉通贯，则包络为相火之脏。由膈膜上通脑筋，即经所云“上焦如雾”是也。中有薄膜两层，包肝裹胃，即经所云“中焦如沤”是也。绕膀胱，遮阴道，以行其气化，即经所云“下焦如渫”是也。以此证之，腹包膜即三焦，夫复何疑？夫三焦者，肾中之脂，与膀胱相峙，有二白膜，通于两肾，贯膂筋，由脉管以入心，即引心火入肾，蒸膀胱之水，化而为气之物也。故心火一动，相火随之。肝胆属乎巽，三焦包络属乎震，震为阳木，火无体，以木为体，《说卦》传言，震为雷，为龙雷之火，三焦包络之流行，即是火之流行也。况以似府外府之大囊，配似脏别脏之小囊，亦天造地设，不可移易者也。若求此膜功用全文，自有《通考》在，兹不具赘。

三阳为腑，三阴为脏，或云心为太阳，肾为太阴，何也？六阳六阴，云手云足，或有他意欤？其标本之传变，经络之起止，可以晓否？

答曰：阴阳分而天地定其位，阴阳交而否泰呈其象，阴阳错综而后变化见焉。万物之中惟人最灵，禀二气淑德以生，故圆其颅，方其趾，而异于物，是以与天地相应，阴阳相参者也。夫心为手少阴，肾为足少阴，人所知也。心肾系背，背为阳，脏为阴，而心肾皆为阴者，五脏系于背内，背虽属阳，其内所包者阴也。阳中有阴，

故能刚柔相济以成其化。盖身中之定位，当如此耳。心复为太阳，肾复为太阴，斯又舍人身而言天地之定位。心赤色象火，应于南方。南方者，天地所长养，阳之所盛处也，则心属老阳，故曰心主太阳矣。肾紫色象水，应于北方。北方者，天地所闭藏之域也，风寒冰冽，则肾属老阴。故曰肾主太阴，虽然，非有异于手足少阴乎？不知其定位既异，正阴阳互根之理，复何害其不同哉？惟施治于病。在经脉者，即随经脉所主。论治于时令胜复，即随时令所主论治。其随时论治，如夏为太阳，病当在心，则宜视心之受邪与否？冬为太阴，病当在肾，则宜视肾之受邪与否？无使逆其时气。心脉不钩，肾脉不石，斯生病矣。然所投药饵，亦皆入手足少阴，非走太阳太阴者，尤参伍错综之要道焉。况心居尊高，并于君主，有显明之象。肾处卑顺，比于外家妇，属蛰封藏之本。得主太阴太阳者以此。心通离卦，离为中女，实含阴德，且萧邱生寒焰，海水成夜磷，复为火有出于阴者之明证，心得主少阴者，又以此也。其六阴六阳，云手云足者，考《经脉篇》手太阴肺，终手大指次指之端，即接手阳明大肠，足阳明胃终足大指之端，即接足太阴脾，手少阴心终手小指之端，即接手太阳小肠，足太阳膀胱终足小指外侧，接足少阴肾，手厥阴心包终手小指次指之端，即接手少阳三焦，足少阳胆终足小指次指之间，即接足厥阴肝。盖十二经脉云手云足，以行手行足而得名耳。岂因足在下属阴，手在上属阳，号为太阳阳明少阳，即不当行于足，号为太阴少阴厥阴，即不当行于阳哉？果尔，则日阳也，设不行寒带，则格林兰济诸国无明也。可乎？月阴也，设不行于赤道，是苏门答喇诸国无夜也。可乎？况三阴之脉起于面，三阳之脉起于腹里，更非若手足之比矣，亦得谓为错行乎？惟知阴阳相互根，即可明乎斯理矣。至标本之传变，《至真要大论》曰：少阳太阴从本，少阴太阳从标，阳明厥阴不从标本，从乎中也。言邃旨深，殊难明晓，故自王太仆以下，皆未通其意，及张戴人始阐发火湿二字，介宾张氏又从而引伸之，厥义益显，说具《类经图翼》中。略谓少阳太阴从本，以少阳本火而标阳，太阴本湿而标阴，标本同气，故当从本。其不言从中，少阳中见木，太阴中见土，木火共化，土金相生也。少阴太阳从本从标者，以少阴本热而标阴，太阳本寒而标阳，标本异气，故或从本，或从标。亦不言从中，少阴之中水，太阳之中火，同本则异标，同标则异本也。若阳明厥阴，其不从标本，从乎中气者，以阳明中湿土，是湿从燥化矣。厥阴中相火，是木从火化矣。故不从标本，从中气也。传变则胜复，盛衰之道生焉。从其化则为常，然后生不息。逆其化则为变，必致灾害起。如木从火化，木具生气，遇火盛而化为炭，反无钻火之功，此太过也。木失其化，木朽火衰，亦少出火之质，此不及也。

燥从湿化，物虽感湿生，干物含湿必霉坏，遂非本性，此亦太过也。土失其化，地薄土湿，则五金不能蕴，此亦不及也。皆标本传变之理，当随其衰王以消息之。是以经言百病之起，有生于本者，有生于标者，有生于中气者。有取本而得者，有取标而得者，有取中气而得者，有取标本而得者，有逆取而得者，有从取而得者，逆正顺也，若顺逆也。又曰人有客气，有同气。有小大不利治其标，小大利治其本。病发而有余，本而标之，先治其本，后治其标。病发而不足，标而本之，先治其标，后治其本也。经言如此，要必明知胜复，而知百病之害矣。经络之起止者，手太

阳之脉起于小指少泽，至头之听宫。手阳明起于次指，至头之迎香。手少阳起于四指关冲，至头之丝竹空。各长五尺，六阳经共长三丈。手太阴之脉起于胸中中府，至大指少商。手少阴脉起于胸中极泉，至小指少冲。

手厥阴起于胸中天池，至中指中冲。各长三尺五寸，六阴经共长二丈一尺。足太阳之脉起于头之精明，至小指至阴。足阳明起于头之头维，至次指厉兑。足少阳起于头之瞳子，至四指窍阴。各长八尺，六阳经共长四丈八尺。足太阴之脉起于足大指隐白，至胸中大包。足少阴起于足心涌泉，至胸中俞府。

足厥阴起足大指大敦，至胸中期门。各长六尺五寸，六阴经共长三丈九尺。督脉起于尾闾长强，至内唇龈交。任脉起于毛际会阴，至下唇承浆。各长四尺五寸，共长九尺。跷脉从足至目内，各长七尺五寸，左右共长一丈五尺。都合一十六丈二尺也。冲脉起于气街，至胸中而散。带脉起于季肋，回身一周。维络于身。阳维起于诸阳会，阴维起于诸阴交也。二脉皆无尺寸之可稽，经络起止尽于是矣。

八脉者，阳跷，阴跷，阳维，阴维，冲，任，督，带也。跷者跷于何经何络，维者维于何经何络，其有形无形，可实指其所在乎？周氏所论，病机体用治法，是耶非耶？

答曰：夫十二经脉，相为表里，阴阳斯偶，前贤论之详矣。顾有偶即有奇，大易之象也。是故复有奇经者焉。冲任督三脉之行。经文班班可考。带脉回身一周，已可考见。惟跷维二脉，起止难详，谨述所得于下焉。跷，履也。跷起于足跟，故曰跷。维，纲也。维络于一身，故曰维。《二十八难》曰：阳跷脉者，起于跟中，循外踝，上行入风池。阴跷脉者，亦起于跟中，循内踝，上行至咽喉，交贯冲脉。阳维阴维者，维络一身，溢蓄不能环流，灌溉诸经者也。故阳维起于诸阳会，阴维起于诸阴交。盖阳跷为足太阳之别，故始申脉。阴跷为足少阴之别，故始少海。二跷既有行道，则不得谓之无形，乃络脉中之气血，行身之左右，与少阳厥阴同行，诸筋所主。然其行不同，皆阴出阳而交于足太阳，阳入阴而交于足少阴，阴阳交互，跷自下而荣于上，大会于目，此跷脉有形之证也。惟既属络脉，则岂若正经有一定循行之路？其不用丈尺计者，以此耳。维则越人明言，灌溉诸经，亦不能究其行度，是本非一脉，故难悉数。虽不曰无形，而未可实指所在，与跷脉有行道可考者异也。阳维主皮肤之气，行身之表。阴维主脂膜之气，行身之里。而阳维以维于诸阳，阴维以维诸阴。诸阳会，诸阴交者。督脉，阳脉之海也。冲脉，阴脉之海也。阴阳维即起于是。何则？饮食入胃，有无数微丝血管，吸其精汁，至领会管，过肺入心。由心下房，出总脉管，以达于督脉，阳维者当起于是。冲为血海，腾精气而上积于胸中，为宗气，人之五味杂投，奚能无毒？谷入于胃，其精者固化血液，而阳明之悍气，不随精者，俱化聚于宗气之区，然后散布周身，阴维者当起于是。斯皆二维之脉，即孙络，故更无行度可计也。况跷脉为病目不瞑，诸脉者皆属于目，跷脉上属目内，则跷脉为络脉不可证耶！维脉为病，发寒热，邪在皮肤，寒热乃生。经

络居内，不当复病寒热，则维为孙络，不又可证耶？至周氏所论，体用病机，治法委曲详尽，先得我心。其论桂枝汤之治维病，不徇入太阳经之谬说，尤卓识也。

或谓昔人皆有二维脉起止之度，如阳维起于少阴，而至太阳，阴维起于少阳，而至厥阴，濒湖李氏载之甚详，何可遽谓孙络乎？斯皆误会叔和微旨也。从少阴斜至太阳。少阴，心也，太阳，膀胱也。由心生血，行于孙络，孙络缠布周身，膀胱主一身之表，故以太阳少阴候阳维之脉也。从少阳斜至厥阴。少阳，三焦也。厥阴，心包也。三焦为腹包膜，血挟阳明之悍气，出诸气街，而遍周包膜，返还入总脉管，从心包复归于心，故以少阳厥阴，候阴维之脉也。且脉络论列所主病多肌肉痺痒，汗出恶风等证，虽所刺有阳谷、金门、仆参、客主人、承山，分肉、筑宾穴，究非一经所主，岂一脉而交贯四五经耶？《素问》阳维之脉，肉里之脉者，脉气与太阳少阳相合。阳维维诸阳。故取太阳少阳泄其邪也，即服桂枝汤反烦不解，先刺风池、风府。卫气行孙络，一日一夜，大会于风府，故取风府也。

观此则维脉属孙络明矣。如实有可稽，何卢、华、仲景、叔和诸书不一称之哉？然络脉孙络从未有以比诸跷维者，狂瞽愚论，复望高明一为发其聩也。

伤寒桂枝汤所治之中风，与小续命汤所治中风，是一是二？而金匱防己地黄汤，与风引汤所主，是异是同？但中风一证，自有真类之说，愈辨愈晦，何所取法？劳以虚名，愈补愈剧，何则？蛊膨云虚云实，孰是孰非？遍察古书，有云关格是证，有云关格是脉，将谁适从？温暑燥湿，疟痢霍乱，各有名义，其所以然，请各抒所见以对。

答曰：中风真类之说，始自金元，古医经未之见也。类中者，即经所谓厥。是桂枝汤所治，邪居浅者。小续命汤所治，邪居深者。病因无异，故药惟以轻重别之。岂若古今录验续命汤，治风热之痹证，而用石膏哉？防己地黄治阴虚于内，邪并于阳。风引治阳实于外，邪并于阴。病既各异，为治是以悬殊。脉有损至，而后证有虚劳。虚曰虚损，劳曰劳瘵，乃一病而二证，概行温补可乎？况有者为实，无者为虚。虚劳者，是非劳力劳心而因逸以致病也，故仲景以血痹类为一门。痹者，闭也。所以大黄虫丸与薯蓣丸为起死之神方，女惑，男风，落山谓之蛊，后人云膨，因其肌肉肿胀，形类乎鼓，外实中空而言，非膨与蛊有别。实指肝言，虚指脾言，云虚云实皆是也，偏攻偏补，非法也。《内经》治以鸡矢醴，非取金制木，木制而土不受木贼，运化之机自生乎？关格是证，覆溢是脉，膈乃关格之始，格即关膈之终，正《素问》所谓阴阳离决，精气乃绝之败证，蒋宝素有考宜参。温者外寒内热，至春而发之病。暑乃天之阳热下降，地之阴湿上腾，湿热互合，化而为暑。湿重病太阴则曰阴暑，热重病阳明则曰阳暑。病暑轻重不同，所以又有中伤之分。水湿火燥，《内经》谓秋伤于湿，言气之本，西昌补秋伤于燥，言气之标。春夏地湿则天热，秋冬天寒则地燥，燥湿固对待，究各有寒化热化之无定也。疟者言其病之暴疟而难骤愈，其脉自弦可知，不弦虽寒热往来，犹非疟。疟，温疟，瘧疟，瘧疟，为证

不一，治不如法，有三患，戕脾元则成疟鼓，蓄肝血则成疟母，耗肾阴则成疟劳。无犯三患，则无论痰疟、食疟、牡疟，自随手奏效。

痢因欲利不得利，其病在利，故曰痢。有虚实，有寒热。桃花汤非治虚寒者乎？白头翁汤非治实热者乎？由此类推，治法可思矣。霍乱是阴阳淆乱，如雨声霍霍而暴注下迫也。属寒者固多，属热者亦常见，但须刻刻顾虑其脾胃耳。因寒宜理中四逆，故姜附不嫌其热。因热宜白虎天水，则膏滑不嫌其寒。若救阴当于大剂参术中佐以牡蛎、白芍，转筋宜在扶持脾胃，参用蜘蛛散以抑风木，审因察证，活法运乎一心，不可泥执一家之言而僨事也。